UNIDADE DE INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-004)

# Laudo Clínico e Epidemiológico: Dengue Clássica com Sinais de Alarme e Plaquetopenia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID Prontuário:** | **DOC-MED-004** | **Paciente:** | **P-04 (Mariana Costa Albuquerque)** | **Idade / Sexo:** | 29 anos \| Feminino |
| **Antropometria:** | 58 kg \| 1,65 m (IMC: 21,3 kg/m²) | **Data/Hora:** | 12/11/2026 - 08:00h | **Código CID-10:** | **A97.1 (Dengue com sinais de alarme)** |

**Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia):** Diagnóstico Canônico: Dengue Clássica com Sinais de Alarme (Aliases: Dengue, Febre Quebra-Ossos, Infecção por DENV). Causa: Vírus da Dengue DENV-2 (Transmitido pelo vetor Aedes aegypti). Fármacos: Paracetamol (Aliases: Acetaminofeno, Tylenol), Ácido Acetilsalicílico (Contraindicado).

## 1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente feminina, 29 anos, arquiteta, residente em área urbana com foco epidêmico documentado de arboviroses, procura atendimento médico no 4º dia de evolução de febre aguda elevada (39,6 °C de início súbito), associada a cefaleia holocraniana intensa, dor retro-orbitária acentuada à movimentação ocular, mialgia e artralgia generalizadas ("febre quebra-ossos"), prostração extrema e surgimento de exantema maculopapular pruriginoso em tronco e membros.

Nas últimas 12 horas, observou-se defervescência parcial da febre acompanhada do surgimento de sinais de alarme clínicos: dor abdominal contínua, vômitos persistentes e gengivorragia leve após escovação dentária.

## 2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

| Parâmetro Clínico / Exame de Imagem | Achados Objetivos e Descrição Propedêutica |
|---|---|
| **Sinais Vitais e Hidratação** | PA deitada: 106/72 mmHg \| PA em pé: 92/64 mmHg (Hipotensão postural) \| FC: 104 bpm \| Temp: 37,8 °C \| Tempo de enchimento capilar: 3 segundos |
| **Prova do Laço e Pele** | Prova do laço francamente POSITIVA (28 petéquias em quadrado de 2,5 x 2,5 cm no antebraço). Exantema maculopapular rubeoliforme difuso com ilhas de pele sã. |
| **Exame Abdominal** | Abdome globoso, doloroso à palpação profunda em hipocôndrio direito, com hepatomegalia dolorosa palpável a 2,5 cm do rebordo costal direito. |
| **Classificação de Risco (Ministério da Saúde)** | Grupo C (Dengue com Sinais de Alarme: dor abdominal contínua, hepatomegalia, sangramento de mucosas, queda abrupta de plaquetas e hemoconcentração). |

## 3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

| Exame / Biomarcador Analisado | Resultado Obtido no Paciente | Valor de Referência / Interpretação |
|---|---|---|
| **Antígeno Viral NS1 (Sorologia Dengue)** | **REAGENTE (Positivo para DENV-2)** | Não Reagente |
| **RT-PCR para Arbovírus** | **Detectado RNA do Vírus da Dengue Sorotipo 2 (DENV-2)** | Não Detectado |
| **Contagem de Plaquetas** | **58.000 /mm³ (Queda de 140.000 em 24h)** | 150.000 - 450.000 /mm³ (Plaquetopenia Severa) |
| **Hematócrito / Hemoglobina** | **47,5% / 15,8 g/dL (Aumento de 18% no basal)** | 36% - 42% (Hemoconcentração por extravasamento) |
| **Transaminases (AST/TGO e ALT/TGP)** | **AST: 184 U/L \| ALT: 142 U/L** | < 40 U/L (Hepatite Transinfecciosa) |
| **Albumina Sérica** | **3,1 g/dL** | 3,5 - 5,2 g/dL |

## 4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

O quadro clínico decorre da infecção aguda pelo Vírus da Dengue Sorotipo 2 (DENV-2), um Flavivírus de RNA fita simples transmitido pela picada da fêmea infectada do mosquito vetor Aedes aegypti. A replicação viral em monócitos e células endoteliais desencadeia tempestade de citocinas pró-inflamatórias, disfunção endotelial transitória com aumento da permeabilidade vascular (extravasamento plasmático) e destruição periférica imunomediada de plaquetas (plaquetopenia).

## 5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Reposição Volêmica Endovenosa Imediata (Protocolo Grupo C): Internação em leito de observação hospitalar com expansão rápida de Soro Fisiológico 0,9% (10 mL/kg na primeira hora), reavaliação seriada do hematócrito a cada 2 horas e manutenção do débito urinário > 1 mL/kg/h.

2. Controle Sintomático de Febre e Dor: Prescrição exclusiva de Paracetamol (Acetaminofeno / Tylenol) 500 a 750 mg a cada 6 horas (dose máxima diária de 3.000 mg devido à elevação de transaminases) ou Dipirona Sódica.

3. Proibição Estrita de Salicilatos e AINEs: Suspensão e alerta em prontuário contra qualquer administração de Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina), Ibuprofeno, Diclofenaco ou Cetoprofeno.

[ALERTA DE GRAFO KAG - CONTRAINDICAÇÃO HEMORRÁGICA E COMPARTILHAMENTO TERAPÊUTICO]:

• Risco de Síndrome Hemorrágica Fatal por AAS (Conexão com DOC-MED-001 e DOC-MED-002): O medicamento Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina) — utilizado no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (DOC-MED-001) — possui contraindicação absoluta na Dengue Clássica com Sinais de Alarme (DOC-MED-004). O AAS inibe irreversivelmente a ciclo-oxigenase plaquetária (tromboxano A2) em um paciente já plaquetopênico (58.000/mm³), precipitando choque hipovolêmico e hemorragia digestiva maciça.

• Sinergia Terapêutica e Resolução de Entidades (Conexão com DOC-MED-006): O analgésico seguro de escolha na Dengue é o Paracetamol (cujos aliases comerciais e químicos Acetaminofeno e Tylenol são unificados pelo motor de Entity Resolution), o qual também atua como terapia analgésica segura compartilhada no manejo da Enxaqueca Crônica com Aura (DOC-MED-006).

Autenticação Digital: Junta Médica de Suporte à Decisão Clínica (GraphRAG & KAG Healthcare) | Registro DOC-MED-004 — Validação Completa.